

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-04 至 2026-06-10。每篇文章单独成页，按 “标题、结论、主要内容、关键信息、启示” 快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库	PDAT 发表日期	MDAT 记录更新	精选入页
35	25	262	5

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

- 下载 PDF
- 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-10 检索；窗口为 2026-06-04 至 2026-06-10，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。官方计数为 EDAT 35、PDAT 25、MDAT 262，去重候选池 266 条。本日按 5 papers/day 和 pubmed-history.json 去重，选择 5 篇未跨日重复 PMID；MDAT-only 条目均明确标注为记录更新而非本周新发表。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	靶向联合 / 挽救治疗 / ASCT 前桥接	R/R LBCL / DLBCL	42255257	R-GDP 联合 venetoclax 作为 R/R LBCL 自体移植前挽救方案：CCTG LY.18 I 期研究	打开文献
2	BTKi / CNSL / 真实世界维持治疗	PCNSL	41770393	PCNSL 一线缓解后维持：BTK 抑制剂对比 lenalidomide 的多中心真实世界研究	打开文献
3	CAR-T / 桥接治疗 / ADC 联合策略	R/R LBCL	41774783	三线及以后 CAR-T 前桥接治疗：放疗与 polatuzumab 方案优于常规化疗的真实世界信号	打开文献
4	ADC / loncastuximab / 临床经验	R/R DLBCL	41942142	loncastuximab tesirine 在 R/R DLBCL 的证据与意大利临床经验：ADC 序贯和桥接场景	打开文献
5	转化研究 / 空间组学 / 免疫表型	DLBCL	41886633	DLBCL 空间转录组揭示浆细胞样表型：进展风险、B2M 改变与 bortezomib 反应模型	打开文献

R-GDP 联合 venetoclax 作为 R/R LBCL 自体移植前挽救方案：CCTG LY.18 I 期研究

PMID 42255257

打开 PubMed 文献

A phase 1 study of R-GDP-venetoclax before autologous transplant in relapsed/refractory large B-cell lymphoma (CCTG LY.18).

靶向联合 / 挽救治疗 / ASCT 前桥接

R/R LBCL / DLBCL

EDAT/MDAT 命中：2026-06-10 近 7 天新增入库/更新

P

适合挽救治疗和潜在 ASCT 的 R/R LBCL 患者

I

R-GDP 三周期联合 venetoclax 剂量递增

C

事后同期 R-GDP 类似队列：不同 venetoclax 剂量水平

O

安全性、推荐 II 期剂量、ORR/CR、EFS、OS、发热性中性粒细胞减少

结论

LY.18 平台研究的第一臂显示，venetoclax 加入标准 R-GDP 三周期挽救治疗总体安全性可管理，推荐 II 期剂量为 400 mg；24 例患者中 ORR 为 70.8%、CR 为 12.5%，与同期 R-GDP 类似队列相比 EFS/OS 未见差异，ORR 数值更高但仍需进一步开发和验证。

主要内容

- 研究背景是 CAR-T 改变了 R/R LBCL 二线格局，但迟发复发、适合 ASCT 的患者仍可能需要有效挽救方案。
- LY.18 是 I 期平台研究，本臂在 R-GDP 基础上递增 venetoclax，目标是确认安全性和推荐 II 期剂量。
- 24 例患者接受治疗，主要不良事件包括血液学毒性、感染、胃肠道症状和疲乏；方案修订后强制 G-CSF，发热性中性粒细胞减少有所改善。
- 事后与同期 R-GDP 队列比较，事件自由生存和总生存未显示差异，提示该组合更适合作为后续验证的假设，而不是已定型的优选方案。

关键信息

- 作者：Sarit Assouline、Anca Prica、Diego Villa、Robert Kridel、Nathalie Johnson、Vishal Kukreti 等。
- 研究类型：I 期临床平台研究；样本量 24 例；核心价值在安全性、剂量和早期疗效信号。
- 推荐 II 期剂量：venetoclax 400 mg，C1 第 4-10 天、C2-C3 第 1-10 天。
- 方向标签：venetoclax、R-GDP、R/R LBCL、ASCT 前挽救、靶向联合、安全性管理。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 24 例 I 期研究、R-GDP+venetoclax 安全性可管理、推荐 II 期剂量、ORR 70.8%、CR 12.5%，以及与同期 R-GDP 队列 EFS/OS 未见差异。

论文作者观点

论文作者观点：R-GDP+venetoclax 有可管理的安全性并显示疗效，但需要进一步开发来判断其相对标准挽救治疗的真实增益。

我的推断

我的推断：后续研究若继续推进，应预先定义适合 ASCT 的迟发复发人群、BCL2/MYC/TP53 等生物标志物和感染/血液学毒性缓解策略；不能把当前 I 期信号写成治疗推荐。

PCNSL 一线缓解后维持：BTK 抑制剂对比 lenalidomide 的多中心真实世界研究

Real-world comparison of BTK inhibitors and lenalidomide as first-line maintenance in primary CNS lymphoma: a multi-center retrospective study.

PMID 41770393

打开 PubMed 文献

BTKi / CNSL / 真实世界维持治疗	PCNSL	MDAT 命中；2026-06-10 近 7 天记录更新，非本周新发表	
P 初治 PCNSL 达缓解后接受一线维持治疗的患者	I BTK 抑制剂维持治疗	C lenalidomide 维持治疗；复发后 BTKi 序贯治疗	O PFS、OS、6 年 PFS 率、多变量 HR、复发后二线 PFS、安全性

结论

这项 71 例初治 PCNSL 缓解后维持治疗的多中心回顾性研究显示，BTKi 维持相较 lenalidomide 维持与更长 PFS 相关，6 年 PFS 率分别为 91.3% 与 41.5%，多变量分析中 BTKi 维持为有利因素；OS 未见显著差异，且 lenalidomide 维持后复发患者转入 BTKi 方案仍可获得二线 PFS 信号。

主要内容

- 研究纳入 23 例 BTKi 维持和 48 例 lenalidomide 维持，均为初治 PCNSL 达缓解后的真实世界维持场景。
- 中位随访 41.2 个月，总体中位 OS 和 PFS 均未达到；BTKi 组中位 PFS 未达到，lenalidomide 组为 61.0 个月。
- BTKi 维持 6 年 PFS 率 91.3%，lenalidomide 维持 41.5%；多变量 HR 为 0.22，提示 PFS 获益与维持药物选择相关。
- OS 两组相近；lenalidomide 组复发后多转入 BTKi 方案，并获得中位 20.5 个月二线 PFS，提示序贯治疗会影响 OS 解读。

关键信息

- 作者：Xiaoli Chang、Zhangyuting He、Huanyuan Wang、Huiying Zhu、Yixian Guo、Dongmei Zou 等。
- 研究类型：多中心真实世界回顾性比较；MDAT 更新命中，需标注不是本周新发表。
- 核心数据：BTKi 23 例、lenalidomide 48 例；BTKi 维持 PFS 优势显著，OS 未显示差异。
- 方向标签：PCNSL、BTKi、lenalidomide、维持治疗、真实世界、序贯治疗。

启示

已验证证据 已验证证据：PubMed 摘要确认 BTKi 维持相较 lenalidomide 维持 PFS 更长、6 年 PFS 率差异、HR 0.22、OS 相近，以及 lenalidomide 复发后转入 BTKi 的二线 PFS 信号。	论文作者观点 论文作者观点：BTKi 可作为 PCNSL 一线缓解后维持治疗的有利选择，但 lenalidomide 维持存在异质性，且后续 BTKi 序贯会影响长期结局解释。	我的推断 我的推断：PCNSL 维持研究应把 BTKi 暴露时间、复发后序贯、分子分层和神经毒性/感染风险作为预设变量；当前证据来自回顾性比较，不能替代随机前瞻验证。
---	--	---

三线及以后 CAR-T 前桥接治疗：放疗与 polatuzumab 方案优于常规化疗的真实世界信号

Outcomes of Bridging Therapy in Patients With Relapsed/Refractory Large B Cell Lymphoma Receiving Third-Line CAR T.

CAR-T / 桥接治疗 / ADC 联合策略

R/R LBCL

MDAT 命中；2026-06-10 近 7 天记录更新，非本周新发表

PMID 41774783

打开 PubMed 文献

P 三线及以后接受 CD19 CAR-T 评估的 R/R LBCL 患者

I 放疗、polatuzumab-based 化疗、常规化疗或激素等桥接治疗

C 不同桥接模式：全病灶覆盖放疗 vs 非全覆盖；无桥接

O ORR、 Δ SUVmax、PFS、OS、CAR-T 输注率、桥接后疾病控制

结论

Princess Margaret 队列显示，在接受三线及以后 CD19 CAR-T 评估的 R/R LBCL 患者中，桥接治疗很常见；相比常规化疗，放疗和 polatuzumab-based 方案的 ORR 与 PFS 信号更好，尤其全病灶覆盖放疗的 ORR 更高，为 CAR-T 前减瘤和疾病控制策略设计提供了真实世界依据。

主要内容

- 219 例 R/R LBCL 接受 CAR-T 评估，188 例完成采集，157 例接受 CAR-T；采集者中 79% 接受桥接治疗。
- 桥接方式包括放疗 41%、polatuzumab-based 化疗 26%、三线化疗 16%、糖皮质激素 17%，另有 21% 未桥接。
- ORR 以 polatuzumab 方案 50% 和放疗 40% 较高，常规化疗为 16%；放疗若覆盖全部活动病灶，ORR 为 51%，非全覆盖为 12%。
- 两年 PFS 以放疗桥接 47% 和 polatuzumab 桥接 37% 较高，常规化疗为 21%；调整分析显示放疗与 PFS 改善相关。

关键信息

- 作者：Inna Y Gong、Meenakshi Jeeva、Katrina Hueniken、Mahmood Aminilari、Massimiliano Marinoni、Anca Prica 等。
- 研究类型：单中心真实世界队列；重点是 CAR-T 前桥接策略，而非 CAR-T 产品本身比较。
- 核心变量：桥接模式、全病灶放疗覆盖、polatuzumab-based 桥接、 Δ SUVmax、ORR、PFS。
- 方向标签：CD19 CAR-T、bridging therapy、polatuzumab、radiotherapy、R/R LBCL、真实世界。

启示

已验证证据
已验证证据：PubMed 摘要确认 219 例评估、188 例采集、157 例输注，桥接方式分布，以及 polatuzumab/放疗相较化疗的 ORR 和两年 PFS 信号。

论文作者观点
论文作者观点：桥接治疗方式与 CAR-T 前响应和后续生存相关，放疗尤其全病灶覆盖放疗、以及 polatuzumab-based 桥接可能是值得重视的策略。

我的推断
我的推断：后续 CAR-T 研究应把桥接方案、病灶覆盖范围、PET 反应和等待输注时间作为核心协变量；但回顾性队列存在选择偏倚，不能把放疗或 polatuzumab 桥接写成固定推荐。

loncastuximab tesirine 在 R/R DLBCL 的证据与意大利临床经验：ADC 序贯和桥接场景

Loncastuximab Tesirine in Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Evidence and Practical Guidance From Italian Clinical Experience.

ADC / loncastuximab / 临床经验

R/R DLBCL

MDAT 命中; 2026-06-10 近 7 天记录更新, 非本周新发表

P

接受至少两线系统治疗后的 R/R DLBCL, 含转化 DLBCL 和不适合强化治疗人群

I

loncastuximab tesirine 单药或作为序贯/桥接策略的一部分

C

既往治疗、其他可用三线选择、不同序贯场景

O

疾病控制、桥接成功、安全管理、后续治疗衔接、真实世界可实施性

结论

这篇综述结合三例意大利临床经验, 概述 loncastuximab tesirine 在二线后 R/R DLBCL 的证据、适用场景、安全性和序贯位置; 病例涉及转化 DLBCL、作为异基因移植桥接以及 R/R DLBCL 治疗序贯, 提示 ADC 在不适合强化治疗或需要后续衔接的人群中有实际应用问题需要系统记录。

主要内容

- 文章定位为证据综述加临床经验, 背景是三线 R/R DLBCL 治疗标准化不足, 但可用治疗选择增多。
- loncastuximab tesirine 是靶向 CD19 的 ADC, 已用于接受至少两线系统治疗后的 R/R DLBCL。
- 作者用三例病例说明其在转化 DLBCL、异基因移植桥接、以及多线治疗序贯中的应用和安全性处理。
- 摘要强调老年或合并症患者常不适合强化疗法, ADC 类药物的定位需要结合序贯、桥接和毒性管理来判断。

关键信息

- 作者: Francesca Bonello、Andrea Aroldi、Alessia Castellino、Lara Mannelli、Elia Boccellato、Serena Rosati 等。
- 研究类型: 综述 + 临床病例经验; 不是新增随机试验, 适合用于证据地图和真实世界问题清单。
- 核心场景: 三线及以后、转化 DLBCL、桥接异基因移植、治疗序贯、老年/合并症患者。
- 方向标签: loncastuximab tesirine、ADC、CD19、R/R DLBCL、real-world、sequencing、bridge。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要确认该文综述 loncastuximab tesirine 临床证据, 并用三例病例展示转化 DLBCL、移植桥接和 R/R DLBCL 序贯应用。

论文作者观点

论文作者观点: 意大利经验可帮助其他已批准地区理解 loncastuximab tesirine 的临床应用、疗效和安全管理。

我的推断

我的推断: ADC 真实世界登记应记录 CD19 表达、既往 CAR-T/双抗暴露、桥接目标、血液学毒性和水肿/肝毒性等安全事件; 但病例经验只能生成问题清单, 不能当成比较疗效证据。

European journal of haematology 2026 Jul <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41942142/>

DLBCL 空间转录组揭示浆细胞样表型：进展风险、B2M 改变与bortezomib 反应模型

Digital spatial profiling uncovers transcriptomic features of distinct plasma cell-like phenotypes in diffuse large B-cell lymphoma.

转化研究 / 空间组学 / 免疫表型

DLBCL

PDAT/MDAT 命中: 2026-06-10 近 7 天发表/记录更新

P

DLBCL 患者样本及其空间转录组/免疫表型数据

I

数字空间分析定义 CD20/HLA-DRA/PRDM1 相关浆细胞样表型

C

DLBCLPCPP vs DLBCLPCPD; 不同表型细胞群

O

12 个月内进展、B2M 改变、免疫功能、TME 重塑、bortezomib 反应预测

结论

Blood Advances 研究用数字空间分析定义 DLBCL 中四类浆细胞样相关表型，发现浆细胞样表型占比高的 DLBCL 与 12 个月内进展风险更高、B2M 改变更多、免疫功能受损和微环境重塑相关；研究还构建了基于表型相关基因的随机森林模型，用于预测 bortezomib 反应，为 DLBCL 分层和靶向敏感性假设提供了空间组学框架。

主要内容

- 研究基于 CD20、HLA-DRA 和 PRDM1 标记，将 DLBCL 内细胞分成非浆细胞样和三类浆细胞样表型。
- 浆细胞样表型占比 >30% 被定义为 DLBCLPCPP，≤30% 为 DLBCLPCPD；两组一线响应相似，但 DLBCLPCPP 的 12 个月内进展比例更高。
- DLBCLPCPP 与较低 Ki-67≥85% 比例、更多 B2M 改变、免疫功能受损和肿瘤微环境重塑相关。
- 作者用表型相关基因构建随机森林模型预测 bortezomib 反应，提示空间表型可能服务于药物敏感性研究。

关键信息

- 作者：Zucheng Xie、Yan Qin、Xuemin Xue、Xinrui Chen、Tongji Xie、Haohua Zhu 等。
- 研究类型：数字空间分析/空间转录组转化研究；重点是表型分层和预测模型，不是治疗干预试验。
- 核心变量：CD20、HLA-DRA、PRDM1、浆细胞样表型比例、B2M 改变、12 个月内进展、bortezomib 反应模型。
- 方向标签：DLBCL、spatial profiling、tumor microenvironment、immune dysfunction、bortezomib、biomarker。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认四类表型定义、DLBCLPCPP 与更高 12 个月内进展比例、更多 B2M 改变、免疫功能受损和 bortezomib 反应预测模型相关。

论文作者观点

论文作者观点：DLBCL 中浆细胞样表型是有预后和生物学意义的空间转录组特征，可用于解释异质性并探索治疗反应。

我的推断

我的推断：后续 DLBCL 新药研究可把空间表型、B2M/抗原呈递、免疫微环境和蛋白酶体抑制剂敏感性作为探索性分层；但随机森林模型需要外部验证，不能直接作为用药依据。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方候选池 266 条，精选 5 篇未跨日重复 PMID：42255257、41770393、41774783、41942142、41886633。覆盖 R/R LBCL venetoclax 挽救联合、PCNSL BTKi 维持、CAR-T 前桥接、loncastuximab ADC 经验和 DLBCL 空间转录组分层。	论文作者观点 入选论文作者共同强调的方向是：R/R DLBCL/CNSL 的新治疗研究正在从单一药物有效性转向治疗前后序贯、桥接、维持、空间组学分层和安全性可实施性；许多证据仍属于 I 期、回顾性或综述/病例经验层级。	我的推断 我的推断是，后续每日监测应优先捕捉能改变研究设计变量的条目：如适合 ASCT 的 R/R LBCL 亚群、PCNSL 维持药物与序贯、CAR-T 桥接模式和全病灶覆盖、ADC 序贯/桥接目标、空间表型与免疫微环境；病例报告可保留但应让位于可形成方案设计变量的研究。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。